



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O VESTIBULAR

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
COREMU/USP**PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE
SAÚDE – USP 2021**

22/11/2020

Instruções

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área profissional em que você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 40 questões objetivas (7 questões de Interpretação de texto; 8 questões de Conhecimentos gerais; 25 questões de Conhecimentos específicos em Medicina Veterinária), com cinco alternativas cada uma, e um estudo de caso, com questões dissertativas. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
4. Durante a prova, são **vedadas** a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação.
5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com **tinta azul**. Escreva com letra legível e não assine as suas respostas, para não as identificar.
6. As respostas das questões dissertativas deverão ser escritas exclusivamente nos quadros destinados a elas. O verso das folhas poderá ser utilizado para rascunho e não será considerado na correção.
7. Duração da prova: **4h30**. Tempo mínimo de permanência obrigatória: **2h30**. Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas.
8. Uma foto sua será coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da FUVEST, nos termos da lei.
9. Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução da folha de respostas acompanhada deste caderno de questões.

Declaração

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala.

ASSINATURA

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova.

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02

A obesidade é considerada uma prioridade global de saúde pública por sua magnitude e relação com doenças crônicas. Em 2013, atingiu 20% dos adultos brasileiros, sendo 56,9% com sobrepeso (IBGE, 2015) e, embora políticas nacionais tenham sido instituídas (Dias et al., 2017), trata-se de um cenário de difícil reversão e que demanda articular o cuidado individual com ações que afetem o ambiente obesogênico (Poston et al., 1998; Swinburn et al., 2015). Além disso, a baixa efetividade das intervenções individuais pautadas em “modelos assistenciais” biologicistas e curativos impõe reflexões sobre os caminhos para a inovação das práticas de cuidado (Fertonani et al., 2015; Roberto et al., 2015).

O conceito de “modelo assistencial” vem sendo problematizado desde a década de 1970, quando emergiram as críticas ao denominado “modelo biomédico”. A instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990 impulsionou a reorientação desse modelo na direção da atenção integral à saúde, culminando com a consolidação da Estratégia Saúde da Família (ESF). Além disso, a ótica da promoção da saúde reforçou novas concepções sobre cuidado ao propor ações positivas de saúde, considerando os múltiplos condicionantes do processo saúde/doença (Fertonani et al., 2015; Teixeira, 2006).

O debate sobre modelos assistenciais abarca elementos-chave como as formas de organização das relações entre profissionais e usuários, saberes e técnicas utilizadas para atender as necessidades em saúde, práticas e processos de trabalho (Fertonani et al., 2015). A reorientação dos modelos vigentes é um processo complexo que implica mudanças em distintas dimensões, tais como: (1) gerencial - referente aos mecanismos de condução do processo de reorganização das ações e dos serviços; (2) organizativa - referente ao estabelecimento das relações entre as unidades de prestação de serviços, considerando os níveis de complexidade tecnológica do processo de produção do cuidado; e (3) técnico assistencial, ou operativa, referente às relações que se estabelecem entre o(s) sujeito(s) das práticas e seus objetos de trabalho em vários planos (promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, e recuperação e reabilitação) (Fertonani et al., 2015).

A ESF distingue-se do modelo biomédico por ser fundamentada na integralidade; na construção de Redes de Atenção à Saúde (RAS), tendo a atenção básica como articuladora dos demais níveis por meio dos mecanismos de referência e contrarreferência; na articulação entre promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação; no foco na família, grupos e comunidades; na compreensão dos condicionantes históricos, sociais, culturais do processo saúde/doença; nas relações acolhedoras, de vínculo,

compromisso e corresponsabilidade entre os profissionais de saúde, gestores e população; e na equipe multiprofissional (Fertonani et al., 2015; Teixeira, 2006). Tais características estão relacionadas com as dimensões “organizativa” e “técnico assistencial” de reorientação dos modelos assistenciais, incluindo as “práticas de cuidado” (Mattos, 2001).

BURLANDY, L. et al. “Modelos de assistência ao indivíduo com obesidade na atenção básica em saúde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil”. Cad. Saúde Pública. 2020, v. 36, n. 3, p. 01-19.

01

Segundo o texto, é correto afirmar que

- (A) a instituição do SUS reforçou o modelo biomédico, que prima pela atenção integral à saúde, concretizada na formação de equipes multiprofissionais.
- (B) o modelo biomédico foi uma resposta às problematizações levantadas desde a década de 1970 sobre os modelos assistenciais em saúde pública.
- (C) a Estratégia Saúde da Família, que resultou de reorientações no modelo biomédico estimuladas pela implantação do SUS, assume a integralidade como um de seus aspectos constitutivos.
- (D) os modelos assistenciais biologicistas e curativos inovaram as práticas de cuidado realizadas no país, especialmente no âmbito da obesidade.
- (E) as políticas nacionais instituídas no combate à obesidade, que articularam o cuidado individual a ações sobre o ambiente obesogênico, têm conseguido reduzir a incidência de obesidade.

02

Assinale a alternativa correta de acordo com o texto:

- (A) a Estratégia Saúde da Família (ESF) trouxe mudanças às dimensões gerencial, organizativa e operativa dos modelos assistenciais.
- (B) as práticas de cuidado passaram a integrar o modelo biomédico, a partir da construção das Redes de Atenção à Saúde (RAS).
- (C) o foco no acolhimento, no vínculo, no compromisso e na corresponsabilidade entre profissionais de saúde, gestores e população representa uma reorientação na dimensão gerencial da ESF.
- (D) o debate sobre os modelos assistenciais em saúde pública tem negligenciado as dimensões organizativa e operativa.
- (E) a compreensão dos condicionantes históricos, sociais e culturais do processo saúde/doença integra as novas concepções sobre as práticas de cuidado nos modelos assistenciais em saúde pública.

TEXTO PARA A QUESTÃO 03

Francisco & Diez-Garcia (2015) reiteram que a abordagem terapêutica da obesidade tem se detido no modelo biológico do qual derivam estratégias que são insuficientes para dar conta da complexidade do problema. Analisam vários estudos que indicam como as atitudes negativas dos próprios profissionais de saúde em relação ao excesso de peso podem afetar o tratamento e o julgamento clínico, dificultar o acesso aos serviços de saúde e condicionar, inclusive, o tempo de consulta. Estudos abordados pelos autores sinalizam que a maioria dos profissionais entrevistados não se sente qualificado para tratar a obesidade, o que os leva a sentimentos de limitação e frustração. Mesmo entre grupos especializados e interessados em tratar a obesidade, existem níveis consideráveis de preconceito – próximos ao da população em geral.

Assis (2017) também ressalta as frustrações e outras reações, até mesmo a raiva, expressas por profissionais que lidam com o tratamento da obesidade e com as “resistências” dos usuários em mudar seus hábitos, o que por vezes é atribuído a uma postura de “relaxamento da família” e “falta de disciplina”. Portanto, apesar das evidências científicas de que os fatores psicossociais, genéticos, metabólicos e hormonais condicionam a obesidade, ainda sobressai a hipervalorização das causas “pessoais” (Francisco & Diez-Garcia, 2015) e os profissionais de saúde acabam seguindo esta perspectiva, como observado no presente estudo. “Pacientes obesos” são rotulados como aqueles que não se cuidam ou que não querem se cuidar, que gastam dinheiro público com seu tratamento e são punidos por este dilema moral de culpa individual. A responsabilidade pessoal se torna peça central no processo de estigmatização da pessoa com obesidade, o que só reitera a importância de se problematizar o conceito de autocuidado para que não reforce esta perspectiva culpabilizadora (Francisco & Diez-Garcia, 2015).

BURLANDY, L. et al. “Modelos de assistência ao indivíduo com obesidade na atenção básica em saúde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil”. Cad. Saúde Pública. 2020, v. 36, n. 3, p. 01-19.

03

Segundo o texto, é correto afirmar:

- (A) muitos profissionais de saúde ainda se sentem despreparados para lidar com a obesidade, manifestando níveis consideráveis de preconceito e culpabilizando os pacientes.
- (B) as evidências científicas de que a obesidade está condicionada a fatores psicossociais, genéticos, metabólicos e hormonais reduziram significativamente a estigmatização de pacientes obesos por profissionais de saúde.
- (C) os profissionais de saúde consideram que a postura de “relaxamento da família” e a “falta de disciplina” dos

pacientes obesos são a principal razão para o insucesso no tratamento da obesidade.

- (D) o conceito de autocuidado deve ser problematizado para que o paciente obeso intensifique sua responsabilidade pessoal perante o tratamento, disciplinando-se.
- (E) o modelo biológico prevê estratégias capazes de dar conta da complexidade do problema, por reconhecer a relevância dos fatores genéticos, metabólicos e hormonais na obesidade.

TEXTO PARA A QUESTÃO 04

De acordo com a WHO (1994) [Organização Mundial da Saúde], a maioria dos países da América Latina apresenta elevados índices de dentes cariados perdidos e obturados (CPO-D). No Brasil, o primeiro levantamento nacional realizado pelo Ministério da Saúde (Brasil, 1988) revelou elevada prevalência de cárie dentária em todas as idades, em 1986. Porém, nos últimos anos, vem sendo observada a redução nacional neste índice, conforme estudos de Rosa et al. (1991) e Traebet et al. (2001), provavelmente, devido à expansão da fluoretação da água de abastecimento público em algumas regiões, além da disponibilidade de dentifrícios fluoretados em todo território nacional, a partir de 1989 (Brasil, 1989). Apesar disso, a cárie dentária ainda é considerada uma doença comum na infância, como relata Bedi et al. (2000). Está envolvida num processo dinâmico de saúde-doença, provocado por fatores de ordem geral, locais, sociais, econômicos e culturais.

De acordo com Moysés (2000), a condição social de uma população tem um grande poder de explicar as desigualdades na prevalência de cárie dentária. Estudo realizado pelo autor sugere que piores condições socioeconômicas estão intimamente relacionadas a um consumo mais elevado de açúcar, pior condição de higiene bucal, dificuldade de acesso às escovas e a cremes dentais e dificuldade de acesso aos tratamentos dentários, deixando a população mais exposta a esses fatores de risco e, consequentemente, ocorrendo o aumento na prevalência de cárie dentária.

Moynnham (2002) acrescenta que o consumo de alimentos é um dos fatores determinantes da cárie dentária, enquanto uma doença multifatorial. A cariogenicidade dos alimentos é, portanto, somente um entre vários componentes que poderão determinar a atividade de cárie de um indivíduo.

BATISTA, L. R. V.; MOREIRA, E. A. M.; CORSO, A. C. T. “Alimentação, estado nutricional e condição bucal da criança”. Rev. Nutr. 2007, v. 20, n. 2, p. 191-196.

04

Com base no texto, assinale a alternativa correta:

- (A) as condições socioeconômicas não se mostraram um fator relevante no que se refere às condições de emergência da cárie dentária.
- (B) o consumo de alimentos com teor elevado de açúcar é o principal fator explicativo para a emergência de cáries dentárias.
- (C) a fluoretação da água no abastecimento público consiste em um fator de provável relevância na redução do índice de cáries dentárias no país.
- (D) a cárie dentária não pode mais ser considerada, no Brasil, uma doença comum na infância, por conta da fluoretação da água e dos dentífricos.
- (E) as políticas públicas para controlar a incidência de cáries dentárias não devem considerar o padrão alimentar como um fator relevante.

TEXTO PARA A QUESTÃO 05

Ao final da década de 1970, com a progressiva erosão da capacidade gestora do Estado e o crescimento da consciência de desarticulação administrativa, apontava-se a desestatização para a superação da crise e germinou a necessidade de reforma do Estado (Fiori, 1989; 1997). Novos modelos de gestão e provisão de serviços também foram experimentados em países da Europa, mesmo os de sistemas universais de saúde. Reformas estimularam a concorrência e a conversão dos serviços públicos em mercados públicos como alternativa à privatização, com a possibilidade de financiamento e prestação por entes privados, inclusive na atenção primária à saúde (APS) (Sheaff et al., 2006). Nos anos 1990, o discurso neoliberal de crise econômica/gerencial ganhou força no Brasil, com propostas de superação baseadas em: ajuste fiscal, enxugamento da máquina pública e modificação de seu relacionamento com o setor privado (Diniz; Bosch, 2007). No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a Nova Administração Pública ganhou institucionalidade com a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE). A implantação de Organizações Sociais (OS) configurou-se como estratégia central no PDRAE e a principal expressão de “Organizações Públicas Não-estatais”. Elas estabeleceriam contratos de gestão com o Estado para a prestação de serviços não exclusivos, com ganhos de qualidade, economicidade e ênfase nos resultados. Esse modelo causaria verdadeira revolução na gestão da prestação de serviços na área social.

RAMOS, A. L. P.; DE SETA, M. H. “Atenção primária à saúde e Organizações Sociais nas capitais da Região Sudeste do Brasil: 2009 e 2014”. Cad. Saúde Pública. 2019, v. 35, n. 4, p. 1-15.

05

Na visão dos autores, as Organizações Sociais

- (A) foram responsáveis pela progressiva erosão da capacidade estatal de gerenciar a saúde no país.
- (B) constituem-se em modelos de gestão inspirados em experiências europeias de estatização da esfera da saúde.
- (C) revolucionaram a gestão e a prestação de serviços em saúde, uma vez que resultaram da privatização e da desregulamentação estatal do setor.
- (D) foram implantadas no âmbito do PDRAE como um reflexo do avanço do discurso neoliberal de crise econômica e gerencial no Brasil.
- (E) consistiram em estratégia fundamental do PDRAE para conter gastos estatais, ainda que a qualidade dos serviços tenha sido reduzida.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 06 E 07

[...] a Bioética da Proteção pode ser entendida como a parte da ética aplicada constituída por ferramentas teóricas e práticas que visam entender, descrever e resolver conflitos de interesses entre quem tem os meios que o "capacitam" (ou tornam competente) para realizar sua vida e quem, ao contrário, não os tem. Para isso, estabelecer a prioridade léxica de quem não dispõe de tais meios é primordial para respeitar concretamente o princípio de justiça, já que aplicar o valor da equidade como meio para atingir a igualdade é condição sine qua non da efetivação do próprio princípio de justiça. Os interesses conflitantes redundam em outro tipo de conflitos – chamados conflitos morais – e que só podem ser resolvidos dando suporte (protegendo) aos afetados para que possam desenvolver suas potencialidades e deixem de precisar desta proteção ou – como se diz – de "passar necessidades". De fato, os grupos particularmente vulneráveis, ou literalmente vulnerados (ou afetados), não são capazes, por alguma razão independente de suas vontades, de se defenderem sozinhos pelas condições desfavoráveis em que vivem ou devido ao abandono das instituições vigentes que não lhes oferecem o suporte necessário para enfrentar sua condição de afetados e tentar sair dela.

Nesse sentido, a Bioética da Proteção não se aplica, via de regra, aos indivíduos e às populações que – embora afetados negativamente ou suscetíveis de serem concretamente afetados – conseguem enfrentar essa condição existencial com seus próprios meios ou com os meios oferecidos pelas instituições vigentes e atuantes. Caso contrário, a proteção – considerada condição necessária para que a pessoa vulnerada saia de sua condição de vulneração e desenvolva sua competência para ter uma vida pelo menos decente – poderia ser confundida, pertinentemente, com "paternalismo", porque proteger visa dar o suporte necessário para que o próprio indivíduo potencialize suas capacidades e possa fazer suas escolhas de forma competente, ao passo que

o paternalismo pode, em nome do (suposto) bem-estar do outro, infantilizá-lo e sufocá-lo, impedindo sua capacitação para viver uma vida decente e livre, tornando-o, assim, sempre dependente das escolhas alheias. Em suma, proteger significa dar as condições de vida que cada qual julgue necessárias para capacitá-lo na tomada de suas próprias decisões enquanto ser racional e razoável. Se não for assim, a Bioética da Proteção contraditaria um dos valores básicos das sociedades seculares e democráticas modernas, que é o direito ao exercício da autonomia pessoal e, em alguns casos, o dever de exercê-la, sendo, portanto, responsável por seus atos.

SCHRAMM, F. R. "Bioética da Proteção: ferramenta válida para enfrentar problemas morais na era da globalização". Revista Bioética. 2008, v. 16, n. 1, p. 11-23.

06

Segundo o texto, a Bioética da Proteção prioriza

- (A) os grupos vulneráveis de modo geral, posto que são alvos de conflitos morais que usualmente os levam a abandonar as instituições que os acolhem.
- (B) as populações afetadas negativamente pelas condições vigentes, não diferenciando entre aquelas que conseguem ou não enfrentar sua condição existencial com seus próprios meios.
- (C) as populações vulneradas, uma vez que não conseguem exercer sua autonomia, dependendo dos outros para fazerem as escolhas que lhes proporcionariam uma vida no mínimo respeitosa.
- (D) os vulnerados, aqueles que não conseguem, com seus próprios meios e recursos, independentemente de sua vontade, atingir um estado de vida ao menos digna.
- (E) as instituições, visto que são elas que dispõem das potencialidades para garantir a equidade entre os meramente vulneráveis e os particularmente vulnerados.

07

De acordo com o autor, no âmbito da Bioética da Proteção, proteção e paternalismo são conceitos que se

- (A) opõem, uma vez que a proteção promove a competência para a autonomia pessoal, ao passo que o paternalismo pode tornar o indivíduo dependente das escolhas alheias.
- (B) opõem, já que o paternalismo se centra em instituições estatais, enquanto a proteção prescinde desse tipo de apoio.
- (C) complementam, na medida em que o paternalismo se baseia no olhar do outro sobre o indivíduo vulnerável, enquanto a proteção foca no desenvolvimento do próprio indivíduo.
- (D) complementam, posto que o paternalismo foca os indivíduos mais vulneráveis, ao passo que a proteção prioriza os menos vulneráveis.
- (E) sobrepõem, visto que ambos estão associados à subtração dos indivíduos de um estado de vulnerabilidade para um estado de autonomia.

CONHECIMENTOS GERAIS

08

Entende-se por vigilância epidemiológica

- (A) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, bem como de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (B) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde (fenômenos e processos associados) em populações humanas.
- (D) a difusão e propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários à sua prevenção.
- (E) a prevenção e o controle de doenças transmissíveis, de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e análise de situação de saúde de determinada população.

09

São consideradas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços

- (A) de atenção primária, ambulatoriais especializados e de atenção hospitalar.
- (B) de atenção primária, ambulatoriais especializados e serviços especiais de acesso aberto.
- (C) ambulatoriais especializados, de atenção primária e de atenção de urgência e emergência.
- (D) de atenção de urgência e emergência, ambulatoriais especializados e de atenção primária.
- (E) de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.

10

O processo de trabalho em equipe multiprofissional na saúde foi classificado por Peduzzi (2001) em duas principais modalidades: equipe agrupamento, em que se observa a justaposição das ações; equipe integração, quando ocorre a articulação das ações e a interação dos agentes. Indique os critérios de reconhecimento da equipe agrupamento:

- (A) Comunicação intrínseca ao trabalho; flexibilidade da divisão do trabalho; ausência de autonomia técnica.
- (B) Flexibilidade da divisão do trabalho; projeto assistencial comum; comunicação intrínseca ao trabalho; autonomia técnica de caráter interdependente.
- (C) Ausência de autonomia técnica; comunicação externa ao trabalho; autonomia técnica plena; comunicação estritamente pessoal.
- (D) Autonomia técnica de caráter interdependente; flexibilidade da divisão do trabalho; comunicação externa ao trabalho.
- (E) Comunicação estritamente pessoal; autonomia técnica plena; projeto assistencial comum.

11

Sobre o Acolhimento com Classificação de Risco nos Sistemas de Urgência do SUS, é correto afirmar que

- (A) a avaliação de risco e vulnerabilidade é considerada uma prerrogativa específica dos profissionais de saúde que atendem no serviço de saúde considerado.
- (B) a classificação de risco considera prioritariamente a entrada por filas e ordem de chegada ao serviço de saúde.
- (C) implica escutar atentamente o usuário, seus problemas e demandas, mantendo o foco na doença apresentada, sem considerar outros aspectos, como questões emocionais e o contexto social do usuário.
- (D) consiste em dispositivo técnico-assistencial que altera a forma de fazer a gestão da assistência e de considerar as relações de acesso aos serviços de saúde.
- (E) a avaliação quanto ao risco e à vulnerabilidade deve considerar estritamente o grau de sofrimento físico apresentado pelo usuário.

12

A Bioética estabeleceu como fundamento o respeito à vida humana. Considerando a evolução histórica que resultou no surgimento da Bioética e considerando seus princípios, assinale a alternativa correta:

- (A) A vida é um processo que pode ser considerado contínuo, coordenado e progressivo.
- (B) O método cartesiano contribuiu para a visão integral sobre o paciente e sua saúde.
- (C) A descoberta dos microrganismos no século XIX contribuiu para a mudança de foco da doença para o doente.
- (D) As ações de saúde devem ser pautadas pela correlação entre custos e benefícios.
- (E) De acordo com o princípio da justiça, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Dentro desse princípio, a “objeção de consciência” refere-se ao profissional de saúde dever agir sempre de acordo com a legalidade e com o que é aceito pelo paciente.

13

O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS n.529/2013, com o objetivo de contribuir para a qualidade do cuidado em saúde. Considerando os antecedentes, bem como o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), escolha a alternativa correta:

- (A) A eficiência refere-se ao cuidado baseado no conhecimento científico dirigido a todos que possam se beneficiar desse saber e, ao mesmo tempo, evitando seu uso para os que possivelmente não se beneficiarão.
- (B) A acreditação é uma metodologia de avaliação externa da qualidade, tendo como referência um conjunto de padrões, e é de caráter obrigatório.
- (C) A classificação dos erros em “ativos” e “latentes” facilita a sua identificação e prevenção, no sentido de proteger o paciente. Os erros ativos surgem a partir da gestão, enquanto os erros latentes se referem a atos inseguros como, por exemplo, a troca de um medicamento na hora da sua administração.
- (D) A efetividade refere-se ao cuidado realizado de forma a evitar desperdícios quanto ao uso de equipamentos, suprimentos e energia.
- (E) Entre as mudanças requeridas no ambiente organizacional dos hospitais para a incorporação de uma cultura de segurança, está a recomendação de adotar modelos de cuidado, caracterizado pelo trabalho em equipe interdependente, colaborativo e interprofissional, ao invés de modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente.

14

O Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, com o objetivo de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a sua abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das ações da atenção primária à saúde. Em relação aos NASF, é correto afirmar:

- (A) O NASF atua utilizando como principais ferramentas o Apoio Matricial, a Clínica Ampliada, o Projeto Terapêutico Singular (PTS), o Projeto de Saúde no Território e a Pactuação do Apoio.
- (B) A organização dos processos de trabalho dos NASF tem como foco o território sob sua responsabilidade, priorizando o atendimento direto e individualizado ao usuário.
- (C) O NASF funciona, alternativamente, como porta de entrada do SUS para os usuários.
- (D) A equipe do NASF tem como uma de suas atribuições atuar como equipe de referência para as famílias do território de abrangência.
- (E) O Apoio Matricial caracteriza-se pela dimensão assistencial, que vai produzir ação clínica direta, em detrimento da ação técnico-pedagógica.

15

A estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) tem como objetivo superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que necessita com efetividade e eficiência. Considerando a RAS, é correto afirmar:

- (A) Independente da estruturação da atenção primária à saúde, o aumento dos gastos resulta do tratamento tardio dos agravos e dos incentivos financeiros por desempenho individual.
- (B) Os equipamentos e o conhecimento estruturado devem ser precedidos do foco no trabalho vivo, caracterizado por: vínculo, escuta, comunicação e responsabilização pelo cuidado.
- (C) Na rede de atenção às urgências e emergências, a atenção primária à saúde também cumpre o papel de coordenação dos fluxos e contrafluxos da rede.
- (D) O modelo de atenção preconizado pelo SUS é centrado no atendimento à demanda espontânea e na agudização das condições crônicas.
- (E) A economia de escala é um dos fundamentos da RAS e caracteriza-se pelo aumento dos custos médios, à medida que aumenta o volume das atividades, e pela distribuição dos custos fixos por um maior número de atividades.

MEDICINA VETERINÁRIA

16

Algumas alterações dermatológicas surgem nos animais em decorrência de doenças sistêmicas, como a púrpura, que é uma lesão elementar definida como:

- (A) vermelhidão por vasodilatação, que cede à digitopressão.
- (B) alteração de cor por extravasamento de hemácias.
- (C) formação sólida, relacionada à inflamação ou neoplasia.
- (D) coleção líquida decorrente de perda tecidual, por inflamação.
- (E) alteração de espessura, relacionada à cronicidade.

17

A classificação das anemias a partir do hemograma é de grande importância para a determinação de sua origem e gravidade. Em casos de um animal com anemia, com VCM (volume corpuscular médio) diminuído e CHCM (concentração de hemoglobina corpuscular média) normal, a classificação que se dá para a anemia e sua possível causa são, respectivamente,

- (A) anemia microcítica normocrômica; deficiência de ferro.
- (B) anemia macrocítica hipocrômica; intoxicação por cobre.
- (C) anemia normocítica normocrômica; insuficiência renal.
- (D) anemia microcítica hiperocrômica; hemólise aguda.
- (E) anemia microcítica normocrômica; hemorragia aguda.

18

Diversas substâncias podem provocar coloração avermelhada ou enegrecida à urina. Algumas dessas substâncias são:

- (A) Hematina parasitária, bilirrubina e hematóidina.
- (B) Hemoglobina, hemácias e mioglobina.
- (C) Mioglobina, hemossiderina, melanina.
- (D) Hematóidina, mioglobina e lipofuscina.
- (E) Lipofuscina, hemossiderina e hematina parasitária.

19

Quanto aos achados do exame de urina, relativos à densidade, é correto afirmar:

- (A) Fitas reagentes têm boa sensibilidade e especificidade para avaliação desse parâmetro.
- (B) Azotemia pré renal por desidratação causa hipostenúria.
- (C) Esse parâmetro não tem relação direta com azotemia.
- (D) O teste de privação hídrica é indicado em pacientes azotêmicos.
- (E) Isostenúria em paciente azotêmico sugere incapacidade de concentrar urina.

20

Em relação à percussão e auscultação do sistema respiratório, assinale a alternativa correta:

- (A) A percussão do tórax em cães e gatos deve ser realizada com a técnica digitodigital, e o som normal obtido é o timpânico.
- (B) A percussão dos seios paranasais em equinos deve ser realizada com a técnica martelo pleximétrica, e o som normal obtido é o claro.
- (C) O sibilo é um ruído patológico, semelhante a um assobio, auscultado sobre o tórax e indica estreitamento de vias aéreas.
- (D) O ruído laringotraqueal é um ruído normal que pode ser auscultado sobre a região do tórax.
- (E) A crepitação é um som patológico que pode ser obtido na percussão do tórax em casos de pneumonia.

21

As seguintes alterações circulatórias podem ser observadas em caso de obstrução do fluxo sanguíneo:

- (A) Hiperemia, hipovolemia e edema.
- (B) Hemostasia, congestão e choque.
- (C) Congestão, edema e hemorragia.
- (D) Choque, edema e lesão de isquemia-reperusão.
- (E) Hipovolemia, hemorragia e coagulação intravascular disseminada.

22

Quanto aos fios de sutura, é correto afirmar:

- (A) Devem ser escolhidos pelo comportamento no tecido, estrutura e origem.
- (B) Os monofilamentosos têm maior resistência em relação aos multifilamentosos.
- (C) O catgut é um fio absorvível que provoca pouca reação inflamatória.
- (D) A poliglactina 910 é monofilamentoso e não mantém a força tensil.
- (E) O fio de seda é multifilamentoso e indicado para áreas contaminadas.

23

As úlceras em cavidade oral observadas em animais com insuficiência renal crônica devem-se à:

- (A) lesão cáustica, devido à produção de amônia, após a degradação da ureia salivar por bactérias.
- (B) isquemia de vasos da cavidade oral, induzida por vasoconstrição periférica.
- (C) trombose de vasos periféricos, ocasionada por liberação de citocinas pelos rins em falência.
- (D) gangrena úmida, devido à proliferação bacteriana na cavidade oral.
- (E) hipotensão arterial, redução da pressão intracraniana, analgesia e miorelaxamento.

24

Indique a alternativa que apresenta corretamente a associação entre um tipo de sutura, uma vantagem de seu uso e um local em que pode ser utilizada:

- (A) Ponto simples separado; apresenta um fechamento anatômico mais preciso; indicada para órgãos ocos.
- (B) Sutura de Parker-Kerr; apresenta facilidade para remoção da sutura; indicada para extremidades de vísceras.
- (C) Sutura festonada; apresenta boa coaptação e segurança em casos de falha da sutura; indicada para ruptura de tendão.
- (D) Cushing; apresenta bom fechamento da ferida pela inversão dos bordos; indicada para órgãos ocos.
- (E) Sutura intradérmica contínua; reduz a tensão em áreas de grande tensão dos bordos; indicada para pele.

25

A paratuberculose (ou doença de Johne) é uma doença infecciosa debilitante, provocada pelo *Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis*, que acomete ruminantes. Seus achados macro e microscópicos são, respectivamente,

- (A) adelgaçamento da parede do intestino, com visualização dos vasos linfáticos; linfócitos e plasmócitos na lâmina própria do intestino e em linfonodos mesentéricos.
- (B) espessamento da parede do intestino e aspecto grosseiro da mucosa; neutrófilos e eosinófilos na lâmina própria do intestino e nos linfonodos mesentéricos.
- (C) espessamento da parede do abomaso e do duodeno, com hemorragia na mucosa; macrófagos epitelioides na lâmina própria do intestino e granulomas em linfonodos mesentéricos.
- (D) adelgaçamento da parede do abomaso e intestinos, com conteúdo fibrinoso; macrófagos espumosos e fibrina na lâmina própria do intestino e nos linfonodos mesentéricos.
- (E) espessamento da parede do intestino e aspecto cerebriforme da mucosa; macrófagos epitelioides na lâmina própria do intestino e granulomas em linfonodos mesentéricos.

26

Poliúria e polidipsia nas espécies canina e felina são manifestações extremamente comuns. A causa mais frequente e seu respectivo mecanismo são:

- (A) Piometra por hipertocinidade medular.
- (B) Pielonefrite por ação do hormônio antidiurético.
- (C) Insuficiência hepática por perda de hipertonicidade medular.
- (D) Doença renal crônica por diurese osmótica.
- (E) Diabetes mellitus por excesso de catecolaminas.

27

Ao examinar um cão com dor abdominal, o médico-veterinário suspeita de intussuscepção. Para confirmar o diagnóstico, deve-se solicitar um exame de imagem. Qual o exame de escolha e por quê?

- (A) Ultrassonografia abdominal; é o exame que melhor permite a visualização das características clássicas de uma intussuscepção: aparência pregueada / franzida das alças intestinais com pequenas áreas de gás.
- (B) Exame radiográfico abdominal; é o exame que melhor permite a visualização das características clássicas de uma intussuscepção: visualização de anéis concêntricos hiper e hipoeoicos (lesão em alvo ou em “olho de boi”).
- (C) Tomografia abdominal; é o exame que melhor permite a visualização das características clássicas de uma intussuscepção: visualização de anéis concêntricos hiper e hipoeoicos (lesão em alvo ou em “olho de boi”).
- (D) Exame radiográfico abdominal; é o exame que melhor permite a visualização das características clássicas de uma intussuscepção: aparência pregueada / franzida das alças intestinais com pequenas áreas de gás.
- (E) Ultrassonografia abdominal; é o exame que melhor permite a visualização das características clássicas de uma intussuscepção: visualização de anéis concêntricos hiper e hipoeoicos (lesão em alvo ou em “olho de boi”).

28

Assinale a alternativa correta sobre a brucelose:

- (A) A *Brucella sp* e suas toxinas permanecem viáveis mesmo após a pasteurização do leite. Para evitar o contágio por meio do leite, este deve passar por processamento industrial.
- (B) A bactéria provoca lesão microscópica patognomônica, caracterizada por granulomas contendo lesão denominada de fenômeno de Splendore-Hoeppli.
- (C) O diagnóstico pode ser realizado por meio dos testes da imunofluorescência direta e indireta e da reação intradérmica de Montenegro, além do exame histopatológico.
- (D) Ingestão de alimento e água contaminados, ingestão de secreções genitais e fetos abortados, cópula e inseminação artificial são as principais maneiras de contágio.
- (E) Como sinais clínicos, os animais podem apresentar, principalmente, descarga nasal, ocular e vaginal purulenta e sinais neurológicos, como andar em círculos e opistótono.

29

Um felino, macho, não castrado, 2 anos de idade, sem raça definida, que vive num abrigo na zona leste de São Paulo e tem acesso à rua, apresenta múltiplas lesões ulceradas em região cefálica e membros, com evolução de alguns meses. Qual a suspeita clínica mais provável e o exame mais importante para a confirmação do diagnóstico?

- (A) Dermatofitose e exame direto.
- (B) Esporotricose e cultivo micológico.
- (C) Carcinoma e exame histopatológico.
- (D) Micobacteriose e cultivo bacteriológico.
- (E) Criptococose e exame citológico.

30

Em relação ao tratamento cirúrgico das sinusites em equinos, é correto afirmar:

- (A) As sinusites secundárias ocorrem principalmente por alterações dentárias e devem ser tratadas apenas com antibioticoterapia sistêmica e lavagem do seio paranasal.
- (B) As sinusites primárias ocorrem principalmente por alterações dentárias e estas devem ser tratadas juntamente com a lavagem do seio paranasal e uso de antibioticoterapia sistêmica.
- (C) As sinusites secundárias ocorrem principalmente após pneumonias e devem ser tratadas apenas com antibioticoterapia sistêmica.
- (D) As sinusites primárias ocorrem principalmente após pneumonias e devem ser tratadas apenas com antibioticoterapia sistêmica e lavagem do seio paranasal.
- (E) As sinusites secundárias ocorrem principalmente por alterações dentárias e estas devem ser tratadas juntamente com a lavagem do seio paranasal e uso de antibioticoterapia sistêmica.

31

São alguns dos componentes da imunidade inata e adquirida, respectivamente,

- (A) muco, microbiota residente e sistema complemento; imunoglobulinas, proteínas do complexo maior de histocompatibilidade e linfócitos.
- (B) anticorpos, plasmócitos e mastócitos; leucócitos, pele e membranas mucosas.
- (C) imunoglobulinas, proteínas do complexo maior de histocompatibilidade e linfócitos; muco, microbiota residente e sistema complemento.
- (D) leucócitos, pele e membranas mucosas; anticorpos, plasmócitos e mastócitos.
- (E) anticorpos, linfócitos e microbiota residente; barreira hematoencefálica, células de Kupffer e células da glia.

32

Sobre o uso profilático de antibióticos nos procedimentos cirúrgicos e o provável patógeno envolvido, assinale a alternativa correta:

- (A) Cirurgias ortopédicas (bacilos anaeróbios e *Escherichia coli*).
- (B) Cirurgias urogenitais (cocos Gram +, *Staphylococcus spp.*).
- (C) Cirurgias do trato gastrointestinal (cocos Gram +, bacilo Gram – e anaeróbios).
- (D) Feridas penetrantes (aeróbios, Clostrídios e cocos Gram +).
- (E) Cirurgias torácicas (Gram +, Clostrídios e *E. coli*).

33

Sobre a metrite séptica puerperal das vacas leiteiras, é correto afirmar:

- (A) Pode ocorrer por infecção uterina periparto e/ou retardo da involução do útero no pós-parto.
- (B) O animal acometido pode apresentar febre, parorexia, diminuição da produção de leite, artrite e pneumonia.
- (C) Na palpação retal encontra-se um útero de menor tamanho e de consistência fibrosa, fechando-se o diagnóstico com biópsia endometrial.
- (D) O tratamento é simples, realizado apenas com lavagem uterina diária com grande volume de fluido.
- (E) O prognóstico é bom, com a maioria dos casos respondendo bem ao tratamento, sem desenvolver sequelas.

34

O diagnóstico definitivo de *shunt* portossistêmico congênito pode ser realizado

- (A) por meio de radiografia simples, em duas posições, latero-lateral e ventro-dorsal.
- (B) apenas *post mortem*, por meio da visualização de pequenos vasos adjacentes à veia porta, durante a necropsia.
- (C) mediante o exame ultrassonográfico aliado à urografia excretora.
- (D) por meio do exame contrastado denominado portografia mesentérica.
- (E) baseado no histórico clínico, hemograma e exame de função hepática e renal.

35

Um cão da raça Poodle, fêmea, com um ano e meio de idade apresenta impotência funcional de membro pélvico direito há alguns dias. Provavelmente a paciente apresenta luxação de patela. A luxação não é redutível e solicitou-se exame radiográfico. De acordo com os dados e exame físico, classifique o grau e imagem esperada:

- (A) Luxação grau I, sem alterações de imagem.
- (B) Luxação grau II, deformidade óssea ausente.
- (C) Luxação grau III, pouca deformidade óssea.
- (D) Luxação grau IV, tróclea ausente.
- (E) Subluxação, com deformidade óssea moderada.

36

Os tipos de consistência percebidos durante a palpação de um animal são

- (A) crepitante, dura, firme, rugosa, pastosa e áspera.
- (B) crepitante, flutuante, pastosa, dura, firme e mole.
- (C) mole, macia, dura, áspera, rugosa e flutuante.
- (D) macia, crepitante, flutuante, mole e rugosa.
- (E) mole, dura, pastosa, rugosa, macia e áspera.

37

A ruminotomia é um procedimento cirúrgico que pode ser indicado para quais afecções do trato gastrointestinal dos bovinos?

- (A) Indigestão simples; corpos estranhos ruminais; alcalose ruminal; acidose láctica ruminal.
- (B) Acidose láctica ruminal; deslocamento de abomaso à esquerda; putrefação da ingesta ruminal; úlcera de abomaso.
- (C) Corpos estranhos ruminais; úlcera de abomaso; indigestão vaginal; putrefação da ingesta ruminal.
- (D) Alcalose ruminal; indigestão simples; deslocamento de abomaso à esquerda; úlcera de abomaso.

- (E) Acidose láctica ruminal; corpos estranhos ruminais; indigestão vaginal; putrefação da ingesta ruminal.

38

Com relação ao diagnóstico da leishmaniose visceral canina em estágios iniciais, assinale o método diagnóstico mais adequado em termos de sensibilidade diagnóstica:

- (A) Reação em cadeia da polimerase (PCR).
- (B) Intradermoreação.
- (C) Diagnóstico sorológico.
- (D) Citologia aspirativa de linfonodo.
- (E) Cultivo do parasito.

39

Manchas enegrecidas ou esverdeadas que ocorrem nos tecidos após o óbito são chamadas de

- (A) colestase.
- (B) embebição hemoglobínica.
- (C) pseudomelanose.
- (D) hipostase.
- (E) *algor mortis*.

40

Durante o exame de um cão com diarreia, é muito importante saber diferenciar, pelos achados semiológicos, se a origem é do intestino delgado ou do intestino grosso. Em casos de diarreia do intestino delgado, os achados mais comuns são:

- (A) Sem perda de peso; desidratação; volume fecal diminuído; frequência de defecação aumentada; presença de tenesmo; presença de melena; presença de muco.
- (B) Perda de peso; desidratação; volume fecal aumentado; frequência de defecação normal; ausência de tenesmo; presença de melena; ausência de muco.
- (C) Perda de peso; sem desidratação; volume fecal normal; frequência de defecação aumentada; presença de tenesmo; ausência de melena; ausência de muco.
- (D) Sem perda de peso; sem desidratação; volume fecal normal; frequência de defecação aumentada; presença de tenesmo; ausência de melena; presença de muco.
- (E) Sem perda de peso; sem desidratação; volume fecal aumentado; frequência de defecação normal; ausência de tenesmo; ausência de melena; presença de muco.

ESTUDO DE CASO

ANALISE O CASO DESCRITO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DISSERTATIVAS DE 01 A 03.

Um cão, macho, da raça Labrador, com 8 anos de idade, foi trazido ao Hospital Veterinário com sialorreia, aumento de volume abdominal, êmese e dispneia, após ter ingerido grande quantidade de ração. A distensão abdominal ocorreu há cerca de quatro horas. O responsável relatou que já aconteceu anteriormente um episódio semelhante.

A suspeita diagnóstica foi de síndrome dilatação vôlvulo gástrica.

Foi encaminhado ao Raio X, evidenciando-se dilatação gástrica com deslocamento de piloro, sugerindo torção e confirmando o diagnóstico.

01

Em relação ao caso apresentado, antes de o paciente ser encaminhado para o exame de imagem, o que o clínico deve fazer e com qual finalidade? Explique, com base na identificação desse paciente, informações que reforçam o diagnóstico.

RASCUNHO

NÃO SERÁ

CONSIDERADO NA

CORREÇÃO

02

Explique o objetivo do tratamento cirúrgico, qual a técnica operatória mais apropriada para esse paciente (qual a chance de sucesso em evitar a recidiva) e que cuidados devem ser recomendados para evitar recidiva.

03

Sabe-se que o pós-operatório é um período crítico para o paciente. Quais os cuidados em relação à monitoração e os exames complementares? Caso haja alterações, como manejar?

RASCUNHO

NÃO SERÁ

CONSIDERADO NA

CORREÇÃO

